本章数字资源

第十七章 高血压的全科医学处理

学习提要

本章介绍了高血压的定义、病因、危险因素和心血管风险水平分层，从全科医生的角度，通过主观资料（S）、客观资料（O）、初步评估（A）和处置计划（P）等模块对高血压临床案例进行剖析和解读，并对高血压病史采集、体格检查、辅助检查、基层评估与处置、转诊、随访、健康教育和社区防治等全科医学处理思路进行描述。

高血压是一种严重的社区慢性疾病，是最常见的一种需要长期管理的健康问题。高血压是一种“静默杀手”，由于大部分患者是无症状的，患者往往并没有意识到自己有高血压。多个流行病学研究已经表明，高血压与卒中、冠状动脉粥样硬化性心脏病、肾脏疾病、心力衰竭和心房颤动之间具有密切关系。

中国高血压调查最新数据显示，2018 年我国 18 岁及以上居民的高血压加权患病率为 27.5%，与 1958—1959 年、1979—1980 年、1991 年、2002 年和 2012 年进行的 5 次全国范围内的高血压抽样调查相比，患病率总体呈上升的趋势。然而 2015 年的全国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率仅为 51.6%，45.8% 和 16.8%。我国高血压的防控形势极为严峻。

基层医疗机构是主要承担高血压综合防治的基地，全科医生作为主要管理者，更好地规范高血压的诊治和管理显得尤为重要。

临床病例

主观资料（S）：患者，男性，52 岁。因“体检发现血压升高 1 周”于社区卫生服务中心全科门诊就诊。

【问题 1】患者以“血压升高”就诊，需要考虑哪些情况？

思路 1：确认和处理现患问题是全科医生应诊的四项主要任务之首。该患者本次就诊的主要问题是血压升高，势必会考虑到：①血压水平；②病因；③心血管风险水平分层。血压水平分类及定义见表 17-1。

表 17-1 血压水平分类及定义

单位：mmHg

分类	收缩压（SBP）		舒张压（DBP）
正常血压	<120	和	<80
正常高值血压	120~139	和/或	80~89
高血压	≥140	和/或	≥90
1 级高血压（轻度）	140~159	和/或	90~99
2 级高血压（中度）	160~179	和/或	100~109
3 级高血压（重度）	≥180	和/或	≥110
单纯收缩期高血压	≥140	和	<90

注：当 SBP 和 DBP 分属于不同级别时，以较高的分级为准。

知识点

高血压的病因

高血压分为原发性高血压和继发性高血压。原发性高血压约占所有高血压的 90%~95%，其病因为多因素，是遗传和环境因素交互作用的结果。继发性高血压约占所有高血压的 5%~10%，是指某些确定的疾病或病因引起的血压升高，具体疾病或病因主要分为以下 7 类。

1. 肾实质性高血压
2. 肾动脉狭窄及其他血管引起的高血压
（1）肾动脉狭窄
（2）主动脉狭窄
3. 阻塞性睡眠呼吸暂停综合征
4. 原发性醛固酮增多症及其他内分泌性高血压
（1）原发性醛固酮增多症
（2）嗜铬细胞瘤/副神经节瘤
（3）库欣综合征
5. 其他少见继发性高血压
（1）甲状腺功能异常
（2）甲状旁腺功能亢进症
（3）肾素瘤
6. 药物性高血压
（1）激素类药物
（2）作用于中枢神经系统的药物
（3）非甾体抗炎药
（4）中草药类
（5）其他
7. 单基因遗传性高血压

思路 2：心血管风险水平分层需要结合患者的血压水平、危险因素、靶器官损害和伴发临床疾病共同确立。

知识点

高血压的危险因素

高血压的危险因素包括遗传因素、年龄以及多种不良生活方式等，人群中普遍存在危险因素的聚集，随着高血压危险因素聚集的数目和严重程度增加，血压水平呈现升高的趋势，高血压患病风险增高。

危险因素包括可改变因素和不可改变因素，可改变因素包括：①高钠、低钾膳食；②超重和肥胖；③过量饮酒；④长期精神紧张；⑤缺乏体力活动；⑥糖尿病；⑦血脂异常等。不可改变因素包括：①年龄；②高血压家族史等。

【问题 2】作为一名全科医生，如何在问诊中有效采集病史？

思路：面对初诊的高血压患者，应该全面详细地了解患者的病史，问诊要点如下。

1. 您是何时发现血压升高的？
2. 当时有没有头晕、头痛等不适？

NOTES

3. 血压最高水平是多少？——高血压分级的依据。

4. 近期有什么事让您感到紧张或有压力吗？——诱因。

5. 您有腰酸、尿中泡沫增多吗，患过肾脏疾病吗？——除外肾实质性高血压。

6. 您有睡眠中打鼾的现象吗？——除外阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。

7. 您有过毫无诱因的四肢无力吗？——除外原发性醛固酮增多症。

8. 您的血压有没有发作性增高的特点？——除外嗜铬细胞瘤。

9. 您有易怒、多汗吗？——除外甲状腺功能亢进症。

10. 您还患有其他疾病吗？正在服用哪些药物？——除外药物引起的高血压。

11. 女性患者要注意询问月经以及避孕药物使用情况，有生育史的要了解妊娠及生产过程中是否合并妊娠高血压以及产后血压情况——除外药物及妊娠肾病引起的高血压。

12. 有没有活动后气短及夜间平卧时出现呼吸困难？有没有发作过胸闷、胸痛？夜尿多吗？有没有感觉异常或肢体运动障碍？有没有下肢发凉或行走后疼痛？——了解有无靶器官损害、伴发临床疾病的临床表现。

13. 发现后是否到医院做过相关检查？结果如何？——了解是否接受过必要的诊治。

14. 发现血压高后有没有治疗过（包括药物和非药物治疗）？效果如何？平时血压维持在什么水平？——了解是否接受过必要的治疗。

15. 您近期精神、食欲、睡眠如何？大小便正常吗？体重有没有变化？

16. 您有糖尿病、冠心病、血脂异常吗？——了解高血压的危险因素。

17. 您的生活方式如何？盐、酒及脂肪的摄入量，吸烟状况，体力活动量，体重变化，睡眠习惯，工作压力等情况——了解高血压的危险因素。

18. 您亲属中有中年以前就患心脑血管病的吗？——了解家族史。

临床病例（续）

主观资料（S）：患者，男性，52 岁。因“体检发现血压升高 1 周”于社区卫生服务中心全科门诊就诊。

现病史：入院前 1 周，患者体检时发现血压升高，血压最高 167/107mmHg，无头晕、头痛，无胸闷、心悸，无泡沫尿和血尿，无夜尿增多，无打鼾，无易怒、多汗，无乏力，无感觉异常，无肢体运动障碍，无下肢发凉，无行走后疼痛，患者为求诊治，遂来社区卫生服务中心全科门诊就诊。

患者患病以来，精神、食欲、睡眠良好，大小便正常，体重无明显减轻。

既往史：一般情况良好，否认肝炎、结核或其他传染病史，预防接种史不详，无过敏史，无外伤史，无手术史，无输血史。

个人史：长期居住于原籍，大学本科学历，职业为销售经理，工作压力大，喜食咸、油、辣，较少进食蔬菜和水果，不爱运动，未到过牧区及疫区，无冶游史，无吸毒史，吸烟史约 20 年，平均每天 10 支，未戒烟。饮酒史约 20 年，白酒为主，平均每天 15g。

婚育史：24 岁结婚，配偶体健，无离异、再婚、丧偶史。育有 1 子。

家族史：父亲有高血压病史，患病年龄 48 岁；母亲体健；兄弟姐妹体健；1 子体健。无其他疾病家族史和遗传病史。

【问题 3】病史采集结束后，下一步体格检查应该重点关注哪些方面？

思路：体格检查的主要目的是支持、修订或者否定问诊过程中形成的诊断假设，有助于发现继发性高血压的线索、靶器官损害情况、伴发的临床疾病情况。在基层全科门诊的体格检查重点如下。

1. 测量身高、体重，计算体重指数（BMI）。测量腰围和臀围。

2. 测量血压，必要时包括卧位、立位血压和四肢血压。

NOTES

3. 测量脉率。

4. 观察有无库欣综合征满月脸、多血质面容，甲状腺功能亢进性突眼征或神经纤维瘤性皮肤斑等。

5. 触诊甲状腺，听诊甲状腺有无血管杂音。

6. 心脏　视诊：心尖搏动是否向左下移位。触诊：有无心脏震颤及抬举样心尖搏动；叩诊：心界有无扩大；听诊：心率、心脏节律、心音、附加音和杂音。

7. 听诊肺部。

8. 触诊腹部有无肾脏增大（多囊肾）或肿块。

9. 检查四肢动脉搏动，双下肢有无水肿。

10. 大血管　听诊双侧颈动脉、腹主动脉、双侧肾动脉、双侧髂总动脉和股动脉有无杂音。

11. 检查神经系统。

知识点

血压测量

1. 诊室血压测量步骤

（1）要求受试者安静休息至少 5 分钟后开始测量坐位上臂血压，肘部应置于心脏水平。

（2）推荐使用经过验证合格的上臂式医用电子血压计。

（3）使用标准规格的袖带（气囊长 22~26cm、宽 12cm），肥胖者或臂围大者（>32cm）应使用大规格气囊袖带。

（4）首诊时应测量双上臂血压，取血压读数较高者。

（5）测量血压时，应间隔 1~2 分钟重复测量，取 2 次读数的平均值记录。如果 SBP 或 DBP 的 2 次读数相差 5mmHg 以上，应再次测量，取 3 次读数的平均值记录。

（6）老年人、糖尿病患者及出现直立性低血压者，应该加测站立位血压。站立位血压在卧位改为站立位后 1 分钟和 3 分钟时测量。

（7）在测量血压的同时，应测定脉率。

2. 各种血压测量方法评价

（1）诊室血压是我国目前诊断高血压、进行血压水平分级以及观察降压疗效的常用方法。

（2）有条件者应进行诊室外血压测量，用于诊断白大衣高血压及隐匿性高血压，评估降压治疗的疗效，辅助难治性高血压的诊治。

（3）动态血压监测可评估 24 小时血压昼夜节律、直立性低血压、餐后低血压、夜间高血压等。

（4）家庭血压监测可用于评估数日、数周、数月，甚至数年的降压治疗效果和长时血压变异，有助于增强患者在社区居家环境中的自我管理意识，改善患者的治疗依从性，适合患者长期血压监测。随着血压遥测技术和设备的发展，基于互联网的家庭血压远程监测和管理可望成为未来血压管理新模式。精神高度焦虑的患者，不建议频繁自测血压。

临床病例（续）

客观资料（O）：

体温 36.5℃，脉搏 73 次/分，呼吸 16 次/分，血压 165/106mmHg。右上肢血压 165/106mmHg，左上肢血压 162/103mmHg，右下肢血压 175/110mmHg，左下肢血压 175/109mmHg。身高 173cm，体重 78kg，体重指数（BMI）26kg/m^2，腰围 98cm，臀围 103cm。甲状腺无肿大，甲状腺无血管杂音。心尖搏动位于左锁骨中线内 0.5cm 处，未触及心脏震颤和抬举样心尖搏动，心界正常，心音正常，心律齐，心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音，未闻及心包摩擦音。双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。腹软，无压痛

及反跳痛，未触及腹部包块，肝脾未触及，双肾区无叩痛。四肢的脉搏搏动正常。双下肢无水肿。双侧颈动脉、腹主动脉、双侧肾动脉、双侧髂总动脉和股动脉无血管杂音。肌力、肌张力、腱反射正常，深感觉、痛温觉正常，病理反射未引出。

【问题 4】病史采集和体格检查结束后，需要完善哪些实验室检查？

思路：结合患者的病史和体格检查结果，选择实验室检查的思路主要为进一步诊断和评估。基层全科医生为患者选择辅助检查时，还需要考虑自身机构的设备条件以及可利用的医疗资源，因此须完善实验室检查的基本项目，有条件的尽可能完善推荐项目，必要时建议转诊至上级医院完善受基层条件限制的推荐项目和选择项目。

知识点

高血压的实验室检查

1. 基本项目　血常规、尿液分析（尿蛋白、尿糖和尿沉渣镜检）、血生化（血钾、血钠、空腹血糖、血脂、尿酸和肌酐）、尿白蛋白/肌酐比值、尿蛋白定量、心电图等。

2. 推荐项目　超声心动图、颈动脉超声、口服葡萄糖耐量试验、糖化血红蛋白、眼底照相、X线胸片、脉搏波传导速度（PWV）以及踝肱指数（ABI）等。

3. 选择项目　血同型半胱氨酸等。对怀疑继发性高血压患者，根据需要可以选择以下检查项目：血浆肾素活性或肾素浓度、血和尿醛固酮、血和尿皮质醇、血游离甲氧基肾上腺素及甲氧基去甲肾上腺素、血或尿儿茶酚胺、肾动脉超声、肾和肾上腺超声、CT 或 MRI、肾上腺静脉采血以及睡眠呼吸监测等。对有合并症的高血压患者，进行相应的心功能、肾功能、认知功能等检查。对高度怀疑单基因遗传性高血压患者，可考虑行高血压全基因组关联分析（GWAS）检查。

临床病例（续）

客观资料（O）：

实验室检查：血钠 143mmol/L，血钾 4.0mmol/L，血氯 97mmol/L。空腹血糖 5.6mmol/L，餐后 2 小时血糖 7.0mmol/L。血脂：甘油三酯 2.7mmol/L，总胆固醇 4.3mmol/L，高密度脂蛋白胆固醇 0.84mmol/L，低密度脂蛋白胆固醇 1.78mmol/L。尿液分析、尿白蛋白/肌酐比值、尿蛋白定量、肌酐和尿酸未见异常。心电图：窦性心律，正常心电图。

【问题 5】根据病史、体格检查和实验室检查情况，该患者的评估结果是什么？

思路 1：在基层全科门诊的诊疗过程中，全科医生对患者病情作出的评估类似于专科医疗中专科医生作出的临床诊断，两者都是根据患者的主观资料、客观资料作出的判断，但两者又有所不同。全科医疗是以人为中心的健康照顾，不仅要了解患者的躯体疾病的状况，还需要了解患者心理、家庭和社会情况。因此，对患者的评估不仅仅包括对疾病的诊断，还应包括个人心理行为评估和家庭评估等。

思路 2：高血压的诊断不能只根据血压水平，必须对患者进行心血管综合风险的评估并分层。高血压患者的心血管综合风险分层，有利于确定启动降压治疗的时机，优化降压治疗方案，确定更合适的血压控制目标和进行患者的综合管理。目前将高血压患者按心血管风险水平分为低危、中危、高危和很高危 4 个层次（表 17-2）。

思路 3：根据该患者的病史、体格检查和辅助检查结果，考虑该患者为原发性高血压，血压水平分类为 2 级高血压，同时存在危险因素 3 个，包括：吸烟、腹型肥胖、早发心血管病家族史（表 17-3），参照血压升高患者心血管风险水平分层标准，该患者的心血管风险被归类为高危。

NOTES

表 17-2　血压升高患者心血管风险水平分层

其他心血管危险因素和疾病史	血压/mmHg			
	SBP 130~139 和/或 DBP 85~89	SBP 140~159 和/或 DBP 90~99	SBP 160~179 和/或 DBP 100~109	SBP≥180 和/或 DBP ≥110
无	低危	低危	中危	高危
1~2 个其他危险因素	低危	中危	中/高危	很高危
≥3 个其他危险因素，靶器官损害，或 CKD 3 期，无并发症的糖尿病	中/高危	高危	高危	很高危
临床合并症，或 CKD≥4 期，有并发症的糖尿病	高/很高危	很高危	很高危	很高危

注：CKD，慢性肾脏病。

表 17-3　影响高血压患者心血管预后的重要因素

心血管危险因素	靶器官损害	伴发临床疾病
• 高血压（1~3 级） • 男性 >55 岁；女性 >65 岁 • 吸烟或被动吸烟 • 糖耐量受损（2 小时血糖 7.8~11.0mmol/L）和/或空腹血糖受损（6.1~6.9mmol/L） • 血脂异常 TC≥5.2mmol/L（200mg/dl） 或 LDL-C≥3.4mmol/L（130mg/dl） 或 HDL-C<1.0mmol/L（40mg/dl） • 早发心血管病家族史（一级亲属发病年龄 <50 岁） • 腹型肥胖（腰围：男性≥90cm，女性≥85cm）或肥胖（BMI≥28kg/m^2） • 高同型半胱氨酸血症 • 高尿酸血症（血尿酸：男性≥420μmol/L，女性≥360μmol/L） • 心率增快（静息心率 >80 次/min）	• 左心室肥厚 心电图：Sokolow-Lyon 电压 >3.8mV 或 Cornell 乘积 >244mV·ms 超声心动图 LVMI：男≥115g/m^2，女≥95g/m^2 • 颈动脉超声 IMT≥0.9mm 或动脉粥样硬化斑块 • 颈股动脉 PMV≥12m/s（* 选择使用） • ABI<0.9（* 选择使用） • 估算的肾小球滤过率降低［eGFR 30~59ml/（min·1.73m^2）］ 或血清肌酐轻度升高： 男性 115~133μmol/L（1.3~1.5mg/dl）； 女性 107~124μmol/L（1.2~1.4mg/dl） • 尿微量白蛋白：30~300mg/24h 或尿白蛋白/肌酐比值：≥30mg/g（3.5mg/mmol）	• 脑血管病 脑出血 缺血性脑卒中 短暂性脑缺血发作 • 心脏疾病 心肌梗死史 心绞痛 冠状动脉血运重建 慢性心力衰竭 心房颤动 • 肾脏疾病 糖尿病肾病 肾功能受损包括 eGFR<30ml/（min·1.73m^2） 血肌酐升高： 男性≥133μmol/L（1.5mg/dl） 女性≥124μmol/L（1.4mg/dl） 尿蛋白（≥300mg/24h） • 外周血管疾病 • 视网膜病变 出血或渗出 视盘水肿 • 糖尿病 新诊断： 空腹血糖：≥7.0mmol/L（126mg/dl） 餐后血糖：≥11.1mmol/L（200mg/dl） 已治疗但未控制：糖化血红蛋白：（HbA1c）≥6.5%

注：TC，总胆固醇；LDL-C，低密度脂蛋白胆固醇；HDL-C，高密度脂蛋白胆固醇；LVMI，左心室质量指数；IMT，颈动脉内-中膜厚度；BMI，体重指数。

临床病例(续)

初步评估(A):

①原发性高血压 2级 高危;②腹型肥胖;③吸烟。

【问题6】根据目前的评估结果,如何给予患者相应的治疗和管理?

思路1:基层全科医生须征询患者及家属的意见,尤其是患者来诊的愿望,与患者及家属共同决策,讨论患者的治疗和管理。

思路2:高血压治疗的根本目的是降低发生心脑血管并发症和死亡的总体风险。为达到目的,具体采取的措施有如下三点:①生活方式干预;②根据患者的总体风险水平决定是否给予抗高血压药物;③干预可纠正的危险因素、靶器官损害和并存的临床疾病。

思路3:目前国内高血压指南建议降压目标为:一般高血压患者应降至<140/90mmHg;能耐受者和部分高危及以上的患者可进一步降至<130/80mmHg。

知识点

生活方式干预

1. 生活方式干预在任何时候对任何高血压患者(包括正常高值者和需要药物治疗的高血压患者)都是合理、有效的治疗方式,其目的是降低血压、控制危险因素和临床情况。

2. 生活方式干预对降低血压和心血管危险的作用肯定,所有患者都应采用,主要措施如下。

(1)减少钠盐摄入,每人每日食盐摄入量逐渐降至<6g,增加钾摄入。

(2)合理膳食,平衡膳食。

(3)控制体重,使BMI<24kg/m^2;腰围:男性<90cm;女性<85cm。

(4)彻底戒烟,避免被动吸烟。

(5)不饮或限制饮酒。

(6)增强运动,中等强度;每周4~7次;每次持续30~60分钟。

(7)减轻精神压力,保持心理平衡。

知识点

抗高血压药应用的基本原则

1. 常用的六大类抗高血压药物均可作为初始治疗用药,建议根据个体化人群的类型、合并症的情况选择针对性的药物,进行个体化治疗。

2. 应根据血压水平和心血管风险选择初始单药或联合药物治疗,见图17-1。

3. 一般患者采用常规剂量;老年人及高龄老年人初始治疗时通常应采用较小的有效治疗剂量。根据需要,可考虑逐渐增加至足剂量。

4. 优先使用长效抗高血压药物,以有效控制24小时血压,更有效预防心脑血管并发症发生。

5. 对血压≥160/100mmHg、高于目标血压20/10mmHg的高危患者,或单药治疗未达标的高血压患者应进行联合降压治疗,包括自由联合或单片复方制剂。

6. 对血压≥140/90mmHg的患者,也可起始小剂量联合治疗。

思路4:转诊是高血压管理的重要内容之一。基层须转诊人群主要包括起病急、症状重、怀疑继发性高血压以及多种药物无法控制的难治性高血压患者。妊娠和哺乳期女性高血压患者不建议在基层就诊。转诊后2~4周基层全科医生应主动随访,了解患者在上级医院的诊断结果或治疗效果,达标

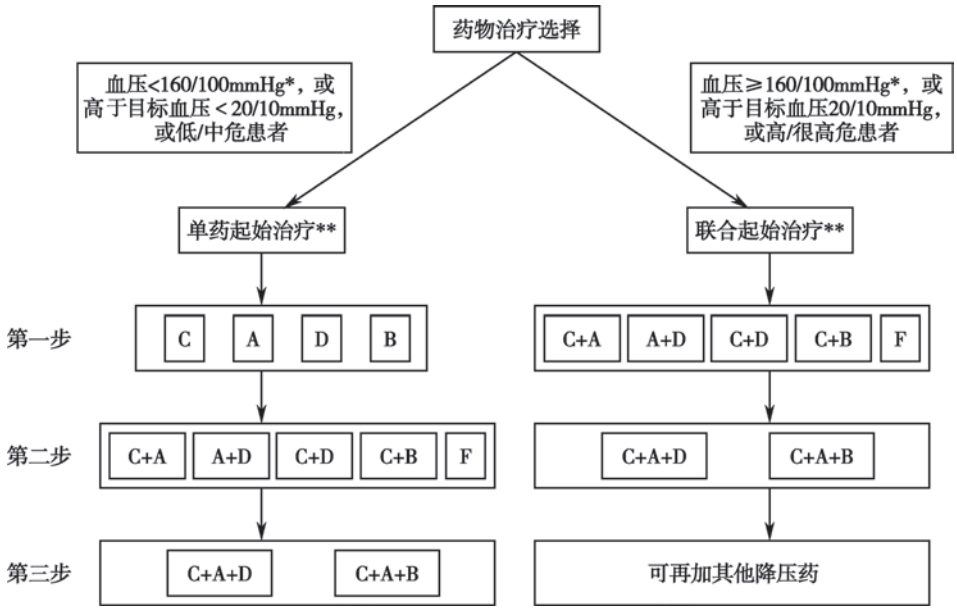


图 17-1　选择单药或联合降压治疗流程图

注：A：血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂；B：β 受体拮抗剂；C：二氢吡啶类钙通道阻滞剂；D：噻嗪类利尿剂；F：固定复方制剂；* 对血压≥140/90mmHg的高血压患者，也可起始小剂量联合治疗；** 包括剂量递增到足剂量。

者恢复常规随访，预约下次随访时间；如未能确诊或达标，或明确为继发性原因所致的血压升高，建议在上级医院进一步治疗。经治疗病情稳定的原发性高血压患者，上级医院应及时将有关治疗信息推送至对应的基层医疗机构，以便及时跟踪随访。

知识点

高血压患者基层转诊至医院的指征

1. 初诊转诊

（1）血压显著升高≥180/110mmHg，经短期处理仍无法控制。

（2）怀疑新出现心、脑、肾并发症或其他严重临床情况。

（3）妊娠和哺乳期女性。

（4）发病年龄 <30 岁。

（5）伴蛋白尿或血尿。

（6）非利尿剂或小剂量利尿剂引起的低血钾（血钾 <3.5mmol/L）。

（7）阵发性血压升高，伴头痛、心慌、多汗。

（8）双上肢收缩压差 >20mmHg。

（9）因诊断需要到上级医院进一步检查。

2. 随访转诊

（1）至少 3 种抗高血压药物（包括 1 种利尿剂）足量使用，血压仍未达标。

（2）血压明显波动且难以控制。

（3）出现怀疑与抗高血压药物相关且难以处理的不良反应。

（4）随访过程中发现严重临床疾病或心、脑、肾损害而难以处理。

3. 急救转诊

（1）意识丧失或模糊。

（2）血压≥180/110mmHg 伴剧烈头痛、呕吐，或突发言语障碍和/或肢体瘫痪。

NOTES

（3）血压显著升高伴持续性胸背部剧烈疼痛。

（4）血压升高伴下肢水肿、呼吸困难，或不能平卧。

（5）胸闷、胸痛持续至少 10 分钟，伴大汗，心电图示至少两个导联 ST 段抬高，应以最快速度转诊，确诊为急性 ST 段抬高型心肌梗死后，考虑溶栓或行急诊冠状动脉介入治疗。

（6）其他影响生命体征的严重情况，如意识淡漠伴血压过低或测不出、心率过慢或过快，突发全身严重过敏反应等。

临床病例（续）

处置计划（P）：

向患者仔细解释病情，消除疑虑，建议转诊至专科或综合医院进一步详细检查。但患者要求先在社区卫生服务中心治疗。与其共同商量后制订治疗方案如下：①立即启动生活方式干预，如低盐低脂饮食，多食蔬菜和水果，戒烟戒酒，加强运动并减重；②立即启动药物治疗，建议二氢吡啶类钙通道阻滞剂联用血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂降压；③暂不转诊专科或综合医院，根据治疗情况再决定后续方案；④建议家庭血压监测；⑤建立个人健康档案，纳入社区高血压患者管理；⑥2 周后随访。

【问题 7】如何对患者进行随访？

思路：根据基层卫生服务机构的条件和医师的情况，建议在基层高血压患者长期随访中，按患者血压是否达标，分为一、二级管理（表 17-4）。该患者的特点为初诊高血压，且血压未达标，应进行高血压的二级管理，随访的频率为 2~4 周，随访的主要内容是观察血压、用药情况、不良反应，影响生活方式改变和药物治疗依从性的障碍；同时应关注心率、血脂、血糖等其他危险因素、靶器官损害和伴发的临床疾病。分级管理可有效地利用现有资源，重点管理未达标的高血压患者，提高血压控制率。

表 17-4 高血压分级随访管理内容

项目	一级管理	二级管理
管理对象	血压已达标患者	血压未达标患者
非药物治疗	长期坚持	强化生活方式干预并长期坚持
随访频率	3 个月 1 次	2~4 周 1 次
药物治疗	维持药物治疗，保持血压达标	根据指南推荐，调整治疗方案

临床病例（续）

患者初诊结束 2 周后，社区卫生服务中心的全科医生对患者进行了电话随访，患者自测血压 130/79mmHg，无明显不适，并与患者预约了社区卫生服务中心的全科门诊初次随访时间。

【问题 8】如何为患者提供健康教育？

思路：高血压患者的健康教育是由高血压管理团队共同负责。高血压管理团队由医生、护士和健康管理师（或医生助理）等组成，团队成员有明确的分工和职责，并要制订团队流程。高血压患者的健康教育内容主要包括五大方面：①高血压的定义；②高血压的危险因素；③高血压的危害；④高血压的生活方式干预和药物治疗；⑤高血压的综合管理。

【问题 9】全科医生如何开展社区人群的高血压管理？

思路：开展以社区为范围的基层医疗卫生服务是全科医生应具备的核心能力。全科医疗的主旨

强调将个体和群体健康照顾融为一体，全科医生应能够将个体疾病诊疗与群体的预防保健有机结合起来。对于高血压的防治，在个体层面的诊疗和管理目标主要是控制血压及其相关危险因素、减少靶器官损害和控制、预防高血压伴发临床疾病。在人群层面社区防治的主要目标是提高高血压知晓率、治疗率和控制率。全科医生需要采取面对全人群、高血压易患（高危）人群和患者的综合防治策略，一级预防、二级预防与三级预防相结合的综合一体化的干预措施。这将有助于将全科医生的服务对象从就医者扩大到未就医者，从患者扩大到健康人和高危个体，有助于将全科医疗服务从患者的诊疗和管理扩大到健康人群和高危人群的预防和管理，提高基层医疗卫生服务的质量和效率。

知识点

社区高血压防治策略

1. 全人群策略

（1）政策发展与环境支持：在提倡健康生活方式（特别强调减少食盐的摄入和控制体重）、促进高血压的早期检出和治疗等方面发展政策和创造支持性环境。

（2）健康教育：应争取当地政府的支持和配合，对社区全人群开展多种形式的高血压防治的宣传和教育。

（3）社区参与：以现存的卫生保健网为基础，多部门协作，动员全社区参与高血压防治工作。

（4）场所干预：健康促进的场所分为 5 类：全市、医院、居民社区、工作场所、学校。根据不同场所的特点制订和实施高血压的干预计划。

2. 高血压高危（易患）人群策略

（1）高血压易患人群的筛选：高血压易患因素主要包括正常高值血压、超重和肥胖、酗酒和高盐饮食。

（2）高血压易患人群的防治策略：①健康体检：健康体检要包括一般询问、身高、体重、血压测量、尿常规、血糖、血脂、肾功能、心电图等；②控制危险因素的水平：与一般人群策略相同，对体检出的高危个体进行随访管理和生活方式指导。

（廖晓阳）

思考题

1. 我国高血压患者的血压控制率较低，治疗依从性差是血压控制率低的主要原因，请讨论可能影响治疗依从性的因素并提出相应的解决策略。

2. 我国社区老年高血压患者的特点是什么？如果您是一名社区全科医生，该如何对他们进行个体化管理？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

NOTES